

Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

BFS-NEOSTIGMINE 0.25

Neostigmin metylsulfat 0,25mg/ml

THUỐC ĐỘC

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần: Mỗi ống 1 ml chứa:

Hoạt chất: Neostigmin metylsulfat 0,25 mg.

Tá dược: Natri acetat trihydrat, acid acetic băng, natri hydroxyd, nước cất pha tiêm vừa đủ.

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Mô tả: Dung dịch trong suốt

pH: 4,5 - 6,5

Chỉ định:

- Mất trương lực ruột và bàng quang.

- Bệnh nhược cơ.

- Giải độc khi dùng quá liều thuốc giãn cơ kiểu cura.

Liều lượng và cách dùng

Neostigmin metylsulfat nên được tiêm rất chậm theo đường tĩnh mạch. Phải luôn chuẩn bị sẵn một bơm tiêm atropin sulfat để đối kháng lại các phản ứng cholinergic nghiêm trọng có thể xảy ra.

Mất trương lực ruột hoặc bàng quang sau phẫu thuật:

- Người lớn: 0,5 – 2,5 mg dùng đường tiêm dưới da hoặc tiêm bắp.

- Trẻ em: 0,125 – 1 mg dùng đường tiêm. Liều có thể thay đổi theo nhu cầu của từng cá thể.

- Người cao tuổi: Không có khuyến cáo về liều dùng cụ thể đối với neostigmin metylsulfat trên người cao tuổi.

Bệnh nhược cơ:

- Người lớn: Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp 1 – 2,5 mg, thời gian tác dụng của một liều thường là 2 – 4 giờ. Tổng liều hàng ngày thường là 5 – 20 mg nhưng có thể dùng liều cao hơn ở một số bệnh nhân nếu cần thiết.

- Trẻ sơ sinh: Bệnh nhược cơ ở trẻ sơ sinh có thể được điều trị khởi đầu với liều tiêm bắp 0,1 mg neostigmin. Sau đó liều dùng phải được hiệu chỉnh theo từng cá nhân. Nhưng mức liều thường dùng là tiêm bắp 0,05 – 0,25 mg hoặc tiêm bắp 0,03 mg/kg mỗi 2 – 4 giờ. Do tính chất tự giới hạn của bệnh ở trẻ sơ sinh, nên giảm liều hàng ngày cho đến khi có thể ngừng hẳn thuốc.

- Trẻ em (dưới 12 tuổi): Có thể tiêm liều 0,2 – 0,5 mg khi có yêu cầu. Liều dùng nên được điều chỉnh theo đáp ứng của bệnh nhân.

Giải độc khi dùng quá liều thuốc giãn cơ kiểu cura:

Không nên sử dụng neostigmin để đảo ngược tác dụng của thuốc chẹn thần kinh – cơ trừ khi bệnh nhân đã có phản ứng hồi phục.

- Người lớn và trẻ em: Một liều duy nhất neostigmin 0,05 – 0,07 mg/kg và atropin 0,02 – 0,03 mg/kg tiêm tĩnh mạch chậm trong hơn một phút thường là đủ để đảo ngược hoàn toàn tác dụng của thuốc giãn cơ không khử cực trong vòng 5 – 15 phút. Liều khuyến cáo tối đa của neostigmin ở người lớn là 5 mg và ở trẻ em là 2,5 mg.

Atropin và neostigmin có thể được sử dụng đồng thời. Tuy nhiên ở bệnh nhân mắc chứng nhịp tim chậm, phải dùng atropin để tăng nhịp tim lên khoảng 80 lần/phút trước khi dùng neostigmin.

Chống chỉ định

- Bệnh nhân quá mẫn với neostigmin hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc.

- Neostigmin không nên được dùng cho bệnh nhân bị tắc nghẽn cơ học đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu, viêm phúc mạc hoặc nghi ngờ mắc các bệnh ở ruột.

- Neostigmin không nên được sử dụng kết hợp với các thuốc giãn cơ khử cực như suxamethonium vì có thể làm tăng tác dụng ức chế thần kinh cơ.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Nên hết sức thận trọng khi sử dụng neostigmin ở bệnh nhân hen phế quản do các tác dụng đối giao cảm của thuốc có thể gây co thắt phế quản.

Rối loạn nhịp tim, với khả năng tiến triển thành suy tim tâm thu, có thể xảy ra ở những bệnh nhân dùng neostigmin đường tiêm tĩnh mạch, trừ khi dùng đồng thời với atropin. Cần hết sức thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân bị nhịp tim chậm, rối loạn nhịp tim hoặc tắc động mạch vành gần đây.

Những bệnh nhân quá mẫn với neostigmin gặp phải phản ứng cholinergic nghiêm trọng với thuốc. Phải luôn có sẵn atropin sulfat như một chất đối kháng với các tác dụng muscarinic của neostigmin.

Nên thận trọng khi sử dụng neostigmin ở những bệnh nhân bị động kinh, tăng trương lực thần kinh phó giao cảm, cường giáp, loét dạ dày hoặc bệnh Parkinson.

Sử dụng các thuốc kháng cholinesterase cho bệnh nhân bị thiếu máu đường ruột có thể gây vỡ các mạch nối hoặc thủng ruột.

Người cao tuổi

Mặc dù không có liều lượng khuyến cáo cụ thể cho người cao tuổi, những bệnh nhân này có thể dễ bị rối loạn nhịp tim hơn so với bệnh nhân trẻ tuổi.

Thuốc gây mê dạng hít

Không nên sử dụng neostigmin metylsulfat cho bệnh nhân đang gây mê bằng cyclopropan hoặc halothan, tuy nhiên có thể sử dụng sau khi ngừng các thuốc gây mê dạng hít này.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có dữ liệu về việc sử dụng neostigmin metylsulfat ở phụ nữ có thai và cho con bú. Phải cân nhắc giữa các lợi ích và nguy cơ có thể xảy ra với mẹ và con trong mọi trường hợp.

Thời kỳ mang thai: Kinh nghiệm điều trị bệnh nhược cơ với neostigmin đã cho thấy không có tác dụng không mong muốn của thuốc trong thời kỳ mang thai. Do mức độ nghiêm trọng của bệnh nhược cơ thường dao động đáng kể, cần có sự chăm sóc đặc biệt để tránh cơn cường cholin do dùng quá liều neostigmin.

Thời kỳ cho con bú: Chỉ có một lượng không đáng kể neostigmin metylsulfat được bài tiết qua sữa mẹ. Tuy nhiên vẫn cần chú ý đến những ảnh hưởng có thể có đối với trẻ bú mẹ.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không có thông tin.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng

Quá liều neostigmin metylsulfat có thể bao gồm: cơn cường cholin, được đặc trưng bởi buồn nôn, nôn, tiêu chảy, tiết nước bọt và đổ mồ hôi, tăng tiết phế quản, co đồng tử, nhịp tim chậm hoặc nhịp tim nhanh, co thắt cơ tim, co thắt phế quản, mất phối hợp, chuột rút, chứng giât cơ và liệt cơ. Liều rất cao có thể dẫn đến các triệu chứng trên hệ thần kinh trung ương như kích động, sợ hãi hoặc bồn chồn. Ngừng tim hoặc liệt hô hấp và phù phổi có thể dẫn đến tử vong. Những bệnh nhân mắc bệnh nhược cơ, có nguy cơ xảy ra quá liều, chứng giât cơ và các tác dụng đối giao cảm bất lợi có thể nhẹ hoặc không xuất hiện khiến cơn cường cholin khó phân biệt với cơn nhược cơ.

Xử trí

Biện pháp xử trí quan trọng hàng đầu là duy trì hô hấp đầy đủ cho bệnh nhân. Có thể cần phải mở khí quản, hút phế quản và dẫn lưu tư thế. Bệnh nhân có thể được hỗ trợ hô hấp cơ học hoặc thở oxy nếu cần thiết.

Nên ngừng sử dụng neostigmin metylsulfat ngay lập tức và tiêm tĩnh mạch 1 – 4 mg atropin sulfat. Có thể dùng thêm liều atropin cứ sau mỗi 5 – 30 phút khi cần thiết để kiểm soát các triệu chứng muscarinic. Nên tránh quá liều atropin vì có thể dẫn đến bài tiết dịch phế quản kéo dài và hình thành các nút phế quản.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Neostigmin tương tác với các thuốc gây mê đường hô hấp hydrocarbon, như cloroform, cyclopropan, enfluran, halothan, methoxyfluran, trichloroethylen, Tác dụng ức chế hoạt tính cholinesterase trong huyết tương của thuốc trị nhược cơ làm giảm sự chuyển hóa của những thuốc gây mê này, dẫn đến tăng nguy cơ độc tính.

Neostigmin, đặc biệt ở liều cao, có thể làm giảm hoạt tính chẹn thần kinh – cơ của quinin.

Khi sử dụng đồng thời với các tác nhân chẹn thần kinh – cơ khử cực như succinylcholin, tác dụng chẹn pha I của các thuốc này có thể kéo dài; tuy nhiên, khi đã dùng thuốc chẹn thần kinh – cơ khử cực trong một thời gian dài và chẹn khử cực đã chuyển thành chẹn không khử cực thì neostigmin có thể đảo ngược tác dụng chẹn không khử cực. Thuốc tiêm neostigmin ức chế một cách hiệu quả tác dụng của các chất giãn cơ không khử cực và có thể sử dụng tương tác này để điều trị làm mất tác dụng giãn cơ sau phẫu thuật. Chẹn thần kinh – cơ đối kháng với tác dụng của neostigmin trên cơ xương.

Trong suy thần, neostigmin có tác dụng kéo dài (1 – 2 giờ) tác dụng của suxamethonium (thuốc này đã cho vào giờ sau mổ ghép thận).

Atropin đối kháng với tác dụng muscarinic của neostigmin và tương tác này được sử dụng để làm mất các triệu chứng muscarinic trong ngộ độc neostigmin.

Tác dụng không mong muốn:

Đối với neostigmin, chưa có thông tin đầy đủ đáng tin cậy để có thể ước lượng chính xác về mức độ nguy cơ đối với các phản ứng có hại khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung phản ứng có hại có liên quan trực tiếp với tác dụng liệt thần kinh đối giao cảm của thuốc và các triệu chứng này đã xảy ra thường xuyên.

Thiếu các triệu chứng như co đồng tử, tăng tiết nước bọt và tăng chảy nước mắt coi như là dấu hiệu của liều neostigmin quá thấp, nhưng phản ứng phụ nặng như co thắt phế quản, hen và chậm nhịp tim là những dấu hiệu của quá liều. Những tác dụng phụ khác nhau như block nhĩ thất và phản ứng tại chỗ tiêm là rất hiếm.

Thường gặp, ADR >1/100

Toàn thân: Tiết nước bọt, ra mồ hôi.

Tuần hoàn: Chậm nhịp tim và hạ huyết áp.

Hô hấp trên: Co thắt phế quản.

Mắt: Co đồng tử.

Ít gặp, 1/1000 < ADR <1/100

Tiêu hóa: ỉa chảy.

Cơ xương: Co cứng cơ (chuột rút).

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.

Các đặc tính dược lực học:

Mã ATC: N07AA01/S01EB06

Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc giãn cơ và ức chế Cholinesterase

Neostigmin làm mất hoạt tính của acetylcholinesterase, là enzym có chức năng trung hoà acetylcholin được giải phóng. Nhờ ức chế enzym này mà sự phân hủy acetylcholin bị kìm hãm. Điều đó dẫn đến kéo dài thời gian tác dụng và tăng hiệu lực của acetylcholin giải phóng tại thụ thể dây thần kinh tân cùng tiết acetylcholin. Hệ quả là các cơ quan chịu sự chi phối của các neuron acetylcholin bị tác động mạnh mẽ hơn. Tác dụng tăng cường này của acetylcholin có thể gây tăng tác dụng giống nicotin và cả tác dụng giống muscarin. Neostigmin làm giảm tác dụng giống cura trên cơ xương và làm giảm tác dụng gây ức chế cơ hô hấp của cura. Neostigmin chỉ có tác dụng đối kháng với các thuốc "giãn cơ tác dụng ngoại vi và không khử cực" kiểu cura. Với những thuốc gây khử cực bền ở tâm vận động, như suxamethonium thì neostigmin không thể đối kháng được. Nếu dùng cùng với suxamethonium, neostigmin gây tăng giãn cơ và gây tăng nguy cơ suy giảm hô hấp. Điều này cần phải được chú ý.

Các đặc tính dược động học:

Neostigmin dạng tiêm là dạng muối metylsulfat thì neostigmin được thải trừ nhanh và bài xuất qua nước tiểu ở dạng không đổi và dạng chuyển hóa. Neostigmin bị thủy phân bởi acetylcholinesterase và cũng được chuyển hóa ở gan. Liên kết với protein ở huyết thanh người khoảng từ 15 đến 25%. Nửa đời của thuốc chỉ từ 1 đến 2 giờ. Neostigmin không qua được nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ một lượng không đáng kể.

Quy cách đóng gói: 1 ml/ống nhựa. 20 ống nhựa/hộp.

Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cum công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội